DR. JOSEHP CHRISTOPHER CASTILLO CUENCA
MÉDICO ANATOMOPATÓLOGO | C.M.P. 56435 R.N.E. 029091
Email: grupopatologia2012@gmail.com | Cel: 986396733

APELLIDOS Y NOMBRES : GARCÉS TRUJILLO, PEPE		**26Q-352**
EDAD : ---	**SEXO :** MASCULINO	
FECHA DE RECEPCIÓN : 22/10/2026	**FECHA DE INFORME :** 26/10/2026	
INDICACIÓN: DR. FLORES SIERRA, BRYAN		

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Se examina producto de enucleación prostática constituido por una pieza lobulada íntegra, con superficie externa pseudo capsular lisa y congestiva, que mide 5.1 x 5.2 x 4.5 cm y pesa 65.0 g.

A las secciones parenquimatosas se reconocen múltiples nódulos confluentes de consistencia elástica, tonalidad pardo blanquecina a amarillenta y cavidades ectásicas milimétricas con coloide, sin áreas de consistencia pétrea ni necrosis. Se incluye muestra representativa en 2 casete(s).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:

Las secciones histológicas revelan tejido prostático con hiperplasia nodular mixta (glandular y estromal). Las unidades acinares exhiben luces dilatadas, plegamientos papilares y cuerpos amiláceos intraluminares, conservando una bicapa celular intacta (cc basales continuas y cc luminales secretoras) sin atipia citológica.

El estroma interglandular presenta hiperplasia fibromuscular, asociado a un leve infiltrado inflamatorio crónico linfohistiocitario focal. La pseudocápsula quirúrgica periférica está íntegra y libre de lesión. No se observan focos de proliferación acinar atípica (ASAP), HGPIN ni neoplasia maligna en el material examinado.

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO:

PRÓSTATA (ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA): HIPERPLASIA NODULAR PROSTÁTICA BENIGNA (COMPONENTE GLANDULAR Y FIBROMUSCULAR).



VALIDACIÓN DIGITAL
Escanee para certificar la autenticidad clínica de este informe.
DOC: 26Q-352

JOSEHP C. CASTILLO CUENCA
MÉDICO ANATOMO PATÓLOGO
C.M.P. 56435 R.N.E. 029091